UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

ENDOCRINOLOGIE

SDD 207 - Ferritine : baisse ou augmentation

Sans patient

Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Ciabrini Mickaëlla **Date de rédaction : 24/11/2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 207 – Ferritine : baisse ou augmentation

Domaine de compétence n°1 : Synthèse des résultats d'examens paracliniques.

Domaine de compétence n°2 : Stratégie diagnostique.

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1 - Interpréter un bilan martial en fonction du tableau clinico biologique.

2 - Prescrire de façon raisonnée et appropriée un examen génétique devant une suspicion d'hémochromatose génétique.

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station :

- Mannequin : NON
- Brancard : NON
- 1 table, 2 chaises, 1 feuille avec les résultats du bilan martial.

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne en endocrinologie, vous recevez Monsieur H 35 ans adressé par son médecin traitant avec les résultats de son bilan martial.

Vous reprenez en vitesse son dossier médical et vous notez principalement une augmentation des ALAT à deux fois la normale et une fatigue débutante de survenue inexpliquée depuis quelques semaines.

Le patient n'a pas d'antécédent particulier et ne prend aucun traitement.

PAS DE PATIENT

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Interpréter le bilan martial du patient et énoncer votre principale hypothèse diagnostique

2. Énoncer les principaux signes cliniques à rechercher

3. Enoncer votre prise en charge diagnostic et thérapeutique

Bilan martial :		
FERRITINE	468 µg / L	(20-200)
COEFFICIENT DE SATURATION DE LA TRANSFERRINE (CST)	57 %	(20-45)
TRANSFERRINE	2,30 g / L	(2-4)

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1 : Interprétation bilan martial et hypothèse diagnostique	
Énonce une hyperférritinémie OU une augmentation de la ferritine sanguine.	
Énonce une augmentation du coefficient de saturation de la transferrine.	
Énonce une transferrine sanguine normale.	
Énonce le diagnostic d'hémochromatose	
Tache 2 : Signes cliniques	
Énonce la recherche d'une **mélanodermie**.	
Énonce la recherche d'une **atteinte ostéo articulaire** avec des arthralgies d'horaire inflammatoire.	
Énonce la recherche d'une **hépatomégalie**.	
Énonce la recherche d'une **atteinte cardiaque** : troubles du rythme, signes d'insuffisance cardiaque. **Côté si 1 sur 2.**	
Énonce la recherche d'un **hypogonadisme** : dépilation, impuissance, diminution libido. **Côté si 2 sur 3.**	
Énonce la recherche d'un **diabète**.	
Tache 3 : principe de prise en charge	
Énonce la réalisation d'un examen génétique à la recherche d'une mutation du gène HFE (C282Y) .	
Énonce la réalisation d'une IRM hépatique avec mesure de la concentration intra hépatique en fer.	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Cocher si fait
Tache 1 : Interprétation bilan martial et hypothèse diagnostique	
Énonce une hyperférritinémie OU une augmentation de la ferritine sanguine.	1
Énonce une augmentation du coefficient de saturation de la transferrine.	1
Énonce une transferrine sanguine normale.	1
Énonce le diagnostic d'hémochromatose .	1
Tache 2 : Signes cliniques et principe de prise en charge	
Énonce la recherche d'une mélanodermie.	1
Énonce la recherche d'une atteinte ostéo articulaire avec des arthralgies d'horaire inflammatoire.	1
Énonce la recherche d'une hépatomégalie.	1
Énonce la recherche d'une atteinte cardiaque : troubles du rythme, signes d'insuffisance cardiaque. **Côté si 1 sur 2.**	1
Énonce la recherche d'un hypogonadisme : dépilation, impuissance, diminution libido. **Côté si 2 sur 3.**	1
Énonce la recherche d'un diabète.	1
Énonce la réalisation d'un examen génétique à la recherche d'une mutation du gène HFE (C282Y) .	1
Énonce la réalisation d'une IRM hépatique avec mesure de la concentration intra hépatique en fer.	1
Énonce la réalisation de saignées thérapeutiques.	1
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge	